内科含诊断 原发免疫性血小板减少症 ★★★（0~3题）

- 血小板过度破坏 血小板生成减少
  - 体液免疫：血小板抗体和补体（IgG，2009）
  - 细胞免疫：CD8 T 细胞
- 表现
  - 育龄期女性多见、血小板数量显著↓（反复皮肤黏膜出血或月经过多）
  - 多无肝脾肿大（2008、2010）
  - 可能可能最可能（2009、2015、2022）
- 检查（2010、2015、2018）
  - 骨髓穿刺（最重要）
    - 巨核细胞数量正常或↑
    - 巨核细胞发育障碍：幼稚巨核细胞↑、产板型巨核细胞显著↓
  - Plt 数量显著↓、Plt 平均体积偏大，但 Plt 功能正常
    - 可有正细胞或小细胞低色素性贫血（合并缺铁贫）
    - 但 WBC 多正常
  - 出血时间 BT 延长、束臂 / 毛细血管脆性试验 CRT 阳性、血凝块收缩不良，但凝血功能正常
  - 伴自免溶（Evans 综合征）者 Coombs 试验阳性、血 UCB ↑、Ret 明显↑
- 治疗
  - 急症（2010、2015、2018）
    - 重症 ITP（Plt ＜ 10 伴活动性出血）、颅内出血（口腔血疱或视物模糊）、近期将实施手术或分娩者
    - 血小板、大剂量糖皮质激素、丙种免疫球蛋白
      促血小板生成药（rhTPO、艾 / 海曲泊帕、罗米 / 普司亭“小艾米”）
      长春碱（免疫抑制剂起效慢、不单独用）、切脾
  - 一线
    - 糖皮质激素（首选）、丙种免疫球蛋白
  - 二线
    - 切脾、促血小板生成药、抗 CD20 单克隆抗体（利妥昔单抗）